



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : دعاء محمد عبدالحليم على
المحافظة : القليوبية الحي / المدينة : شبرا الخيمة ثان العنوان : --
رقم البطاقة : 27507270102742 رقم التليفون : 01125412228 تاريخ تسجيل الإستمارة : 06-10-2026
العمر (تاريخ الميلاد) : 27-07-1975 المهنة : بدون عمل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)
المقرر بما فيه التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة [11129]
قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / / د. / / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: دعاء محمد عبدالحليم علي National ID: 27507270102742	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





Patient Name	: الأستاذ / دعاء محمد عبدالحليم علي	Request No.	: 139515
Patient No.	: 27507270102742	Request Date	: 18/01/2022
Path No.	: 180/2022	Verification Date	: 25/01/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 46 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:

Rt breast mass (BIRADs5)

Nature of the specimen:

tru cut biopsy

Gross Examination:

- Procedure: tru cut biopsy
- Localization: Rt
- Tumor extent
 - o Number: multiple gray white tissue cores up to 1.5cm, totally submitted
 - o Skin involvement: N/A
 - Distance from margins: N/A
 - Lymph nodes number and size: N/A
 - Additional pathologic findings: N/A
 - Immunohistochemistry technique: N/A
 - Frozen section: N/A

Microscopic examination:

- Histological type: IDC
- Grade (differentiation 2+ nuclear pleomorphism 2+ mitosis 2): GII
- Angioinvasion: NO
- Ductal carcinoma in situ: no
- Tumor extent
 - o Number: N/A
 - o Size: N/A
 - o Skin involvement: N/A
 - Lymph node involvement: N/A
 - Resection Margins: N/A

Verified by :

Rana fathy

Printing Date : 07/02/2022 11:07:06

Page 1 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss

Name: دعاء محمد عبد الحليم علي		
MR. : 5159		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالتها		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها		
The patient is a 51-year-old individual with no reported co-morbidities. The patient was diagnosed in 2022 with breast cancer, clinical stage cT4dN1M0, with immunohistochemistry showing ER 0/8, PR 6/8, and HER2 0, and was therefore treated as triple-negative disease. Neoadjuvant chemotherapy was administered followed by a modified radical mastectomy, which yielded final pathology of ypT0 ypN1. Post-operative radiotherapy was given, then six months of adjuvant capecitabine (Xeloda), and the patient has remained on adjuvant tamoxifen to date. On reassessment in July 2026, CT of the chest, abdomen and pelvis demonstrated disease recurrence with a newly developed 2.5 cm pulmonary nodule, an enlarged 17 mm retrocaval lymph node, and widespread lytic osseous lesions. A bone scan performed the same month confirmed extensive osseous metastatic disease, consistent with metastatic recurrence. The biomarker profile remains ER 0/8, PR 6/8, HER2 0. The referring team recommended first-line systemic therapy and bone-directed treatment. The MDT agreed to obtain a new biopsy from an accessible pulmonary nodule (CT-guided). In view of the ER 0/8 PR 6/8 status and progression on tamoxifen, the plan is to start first-line Gemzar-Carboplatin pending biopsy results, together with Zometa administered every 3 months.		
تحريرا في ,		
	الوقت :	التاريخ : 23-09-2026
		الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

Patient Name : الأستاذة / دعاء محمد عبدالحليم على	Request No. : 139515
Patient No. : 27507270102742	Request Date : 18/01/2022
Path No. : 180/2022	Verification Date : 25/01/2022
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 46 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

- o Free /DCIS/ invasive carcinoma
- Histologic response to therapy: N/A
- Additional pathologic findings: N/A

Diagnosis:

Rt breast mass, tru cut biopsy:

Invasive duct carcinoma GII, for (ER, PR, Her2 & Ki67)

Prof. Gamal Abdelaty

Dr. Rana Fathy

Verified by :
Rana fathy



Patient Name	: الأستاذ / دعاء محمد عبدالحليم على	Request No.	: 139515
Patient No.	: 27507270102742	Request Date	: 18/01/2022
Path No.	: 180/2022	Verification Date	: 06/02/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 46 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc. :		IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data:

Rt breast mass (BIRADs5)

Nature of the specimen:

tru cut biopsy

Gross Examination:

• Procedure: tru cut biopsy

• Localization: Rt

• Tumor extent

o Number: multiple gray white tissue cores up to 1.5cm, totally submitted

o Skin involerment: N/A

• Distance from margins: N/A

• Lymph nodes number and size: N/A

• Additional pathologic findings: N/A

• Immunohistochemistry technique: Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9)

• Frozen section: N/A

Microscopic examination:

• Histological type: IDC

• Grade (differentiation 2+ nuclear pleomorphism 2+ mitosis 2): GII

• Angioinvasion: NO

• Ductal carcinoma in situ: no

• Tumor extent

o Number: N/A

o Size: N/A

Verified by :

Rana fathy

Printing Date : 07/02/2022 11:06:11

Page 1 of 2

Printed By : .marwa mohamed youss

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab

المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name	الأستاذة / دعاء محمد عبدالحليم على	Request No.	139515
Patient No.	27507270102742	Request Date	18/01/2022
Path No.	180/2022	Verification Date	06/02/2022
Sex	Female	Financial Category	اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	46 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

- o Skin involvement: N/A
- Lymph node involvement: N/A
- Resection Margins: N/A
- o Free /DCIS/ invasive carcinoma
- Histologic response to therapy: N/A
- Additional pathologic findings: N/A

Diagnosis:

Rt breast mass, tru cut biopsy:

Invasive duct carcinoma GII

Biomarkers:

ER: negative nuclear reaction in tumor cells (Allred score 0/8)

PR: negative nuclear reaction in 35% of tumor cells (Allred score 6/8)

Her-2: negative membrane reaction in tumor cells (score 0)

Ki 67: 15 % nuclear reaction

Prof. Gamal Abdelaty

Dr. Rana Fathy

Verified by :

Rana fathy

Printing Date : 07/02/2022 11:06:11

Page 2 of 2

Printed By : .marwa mohamed youss

Patient Name : الأستاذة / دعاء محمد عبد الحليم علي	Request No. : 13005218
Patient No. : 2750727270102742	Request Date : 01/11/2022
Path No. : 3268/22	Verification Date : 12/11/2022
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - أورام دار السلام
Age : 47 Y	Département : Out Patient
Referreing Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data :

Right breast cancer post NACT

Nature of the specimen : Right MRM specimen collected at 1/11/22.

Gross Examination:

Right MRM specimen measured 18x16x8 cm , with covering skin ellipse measured 15x10cm

- Tumor extent : An ill defined firm greyish white rubbery tumor bed site
- Size: 3x2x2 cm
- Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly
- Distance from margins: 1 cm away from deep margin
- Lymph nodes number and size: 4 LNs up to 0.7 cm .

Microscopic examination:

- Total tumor regression in a previously diagnosed carcinoma
- Lymph node involvement:(1/4)
- Skin involvement : Free nipple and areola
- Resection Margins: Free deep margin
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response

Diagnosis:

Right Breast cancer , post NACT ,MRM specimen :

Total tumor regression in a previously diagnosed invasive carcinoma

- Free nipple and areola
- Free deep margin
- Lymph nodes (1/4)
- Pathologic partial response

Verified by :

dr.esraa magdy

Printing Date : 27/10/2024 09:22:03

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - قورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mizr EL Qadima - Cairo, Egypt



Women's Health Outreach Program

Name: Doaa mohamed abd elhamid

Date: 16/1/2022

Bilateral Full field Digital Mammography and High resolution ultrasound

Technique

- Medio-lateral oblique and CC views
- High resolution ultrasound

Detailed Findings

Left breast

- entirely fatty breast (ACR b).
- No suspicious micro-calcifications or architectural distortion.
- Ultrasound No Solid or cystic lesions.
- Normal skin/ nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary lymph nodes.

right breast

- entirely fatty breast (ACR b).
- Right lower mid line asymmetry in cc view.
- Ultrasound revealed a well define indistinct margin solid mass lesion mid line at 6 o'clock , measures 2.2×1.18 cm , with fine internal vascularity by color doppler study and skin thickness 7mm .
- Right one axillary lymph node (level I) was effaced measuring 1.5×1 cm.

Impression :

- right breast: lower mid line suspicious solid mass lesion as describe above , (BI-RADS 4)
- left breast: normal study (BI-RADS 1).

Best regards,
Dr. walaa hussein
Dr. Eman ali

Best regards,
Dr. walaa hussein



Patient Name: Doaa Mohamed Abu Al Haleem Ali	Date : 30/10/2022
Exam : C.T CHEST	Age : 47 Year(s)
Medical ID:	

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

Findings:

- Clear both lung fields
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Normal appearance of the chest wall.
- Upper abdominal cuts are unremarkable.

OPINION:

- *Essentially normal CT study of the chest.*

Dr: ALAMIN HAIDER

Dr. Amr Farouk M.D.



Patient Name: Doaa Mohamed Abdel Haleem Ali	Date : 27/10/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 49 Year(s)
Medical ID: 667/2022	Pat. ID: 20958

**DIGITAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND
COMPLEMENTARY ULTRASOUND**

Report:

- Right MRM:
 - Operative bed shows no suspicious mass or collection
 - No regional lymphadenopathy.
- Left Breast:
 - ACR B
 - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
 - Complementary ultrasound no suspicious cystic or solid mass lesions.
 - Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
 - Nonspecific axillary LN.

Opinion:

Post right MRM status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)

Normal sonomammography of the left breast (BIRADS 1)

Signature Dr. Wafaa Ali

27/10/2024 3:16 PM